



(19) RU⁽¹¹⁾ 2 141 357⁽¹³⁾ C1
(51) МПК⁶ A 61 N 1/16

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21), (22) Заявка: 97101561/14, 03.02.1997

(46) Дата публикации: 20.11.1999

(56) Ссылки: Биогенный магнетит и магниторецепция. Новое в биомagnetизме / Под ред. Дж.Киршвинка, Д. Джонса, Б.Мак-Фаддена. - М.: Мир, 1989, т.1, с.287. DE 3601743 A1, 23.07.87.

(98) Адрес для переписки:
630117, Новосибирск, ул.Академика Тимакова
2, Международный ин-т космической
антропозологии, А.В.Трофимову

(71) Заявитель:

Автономная некоммерческая организация
"Международный научно-исследовательский
институт космической антропозологии"

(72) Изобретатель: Казначеев В.П.,
Шатарнин А.Ю.

(73) Патентообладатель:

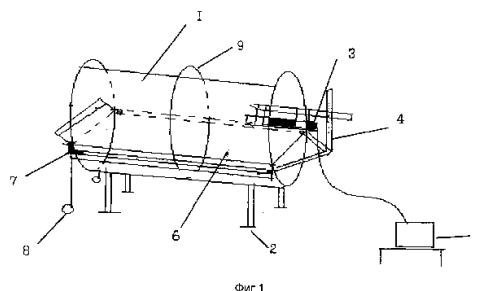
Автономная некоммерческая организация
"Международный научно-исследовательский
институт космической антропозологии"

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОРРЕКЦИИ БИОФИЗИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЧЕЛОВЕКА

(57) Реферат:

Устройство для коррекции биофизического поля человека относится к области научной и практической медицины и может быть использовано для коррекции функциональных нарушений и заболеваний человека, связанных с изменением биофизического поля человека, а также для научных исследований. Устройство включает полый цилиндр из алюминиевого сплава с отшлифованной внутренней поверхностью толщиной 1,5-2 мм, шириной не менее 110 см, длиной не менее 200 см, установленный в горизонтальном положении на опоры. Во внутреннем пространстве цилиндра расположены аппарат гелий-неонового лазера, прикрепленный к корпусу цилиндра в его головном конце на подвижной опоре, так, чтобы луч лазера был направлен по центральной продольной оси цилиндра над

телом пациента, площадка для размещения пациента, закрепленная в горизонтальном положении на стенках цилиндра в его нижней части, выполненная из неметаллического материала и соответствующая по длине и ширине размерам цилиндра в месте ее крепления. Изобретение позволяет улучшить устранение искажений биофизического поля человека. 1 з.п.ф-лы, 8 ил.



Фиг.1



(19) **RU** ⁽¹¹⁾ **2 141 357** ⁽¹³⁾ **C1**
(51) Int. Cl.⁶ **A 61 N 1/16**

RUSSIAN AGENCY
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(21), (22) Application: 97101561/14, 03.02.1997

(46) Date of publication: 20.11.1999

(98) Mail address:
630117, Novosibirsk, ul.Akademika Timakova
2, Mezhdunarodnyj in-t kosmicheskoy
antropoehkologii, A.V.Trofimovu

(71) Applicant:
**Avtonomnaja nekommercheskaja organizatsija
"Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij
institut kosmicheskoy antropoehkologii"**

(72) Inventor: **Kaznacheev V.P.,
Shatarnin A.Ju.**

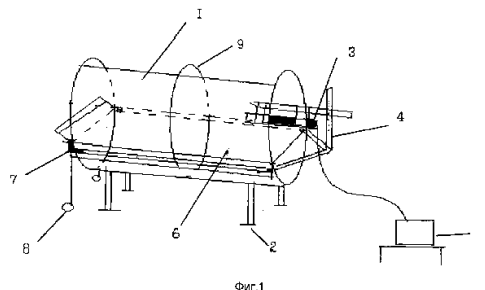
(73) Proprietor:
**Avtonomnaja nekommercheskaja organizatsija
"Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij
institut kosmicheskoy antropoehkologii"**

(54) **DEVICE FOR CORRECTION OF MAN'S BIOPHYSICAL FIELD**

(57) Abstract:

FIELD: scientific and practical medicine.
SUBSTANCE: device may be used for correction of functional disturbances and diseases of man caused by change in biophysical field. Device has hollow cylinder of aluminum alloy with ground internal surface, 1.5-2 mm thick, at least 110 cm wide and not less than 200 cm long, positioned horizontally on supports. Cylinder accommodates helium-neon laser apparatus secured to cylinder body in its "head" end on moving support so that laser beam is directed along central longitudinal axis of cylinder above patient's body. Platform intended for patient's arrangement is secured to cylinder walls in lower part of cylinder in

horizontal position. Platform is made of nonmetallic material, and its length and width correspond to cylinder sizes at point of its attachment. EFFECT: efficient removal of biophysical field distortions. 2 cl, 8 dwg



RU 2 141 357 C1

RU 2 141 357 C1

Изобретение относится к области научной и практической медицины и может быть использовано для коррекции функциональных нарушений и заболеваний человека, связанных с изменением биофизического поля человека, а также для проведения научных исследований.

В связи с установленной взаимосвязью состояния биофизического поля человека с его функциональным состоянием, с течением ряда заболеваний (1) известны попытки разработки устройств для коррекции биофизического поля человека, основанные на воздействии на него "накопленной", "концентрированной" космической энергией (2) либо на изоляции пациента от действия гелиогеофизических полей (3).

Известно устройство для коррекции биофизического поля человека (камера Райха) (2), выполненное в виде замкнутой камеры с плоскими прямоугольными стенками из многослойных чередующихся материалов (изолирующий материал - металл), при этом в качестве металла использована сталь и железо. Предполагается, что принцип действия устройства основан на воздействии на биофизическое поле человека "накопленной" космической энергией. Несмотря на отрывочные указания о возможности применения устройства, до сих пор не получено достоверных сведений об изменении биофизического поля человека при воздействии на него указанным устройством и последующем достоверном изменении функционального состояния человека или терапевтическом эффекте от применения устройства. В связи с этим оно не может быть принято в качестве аналога.

Известно также устройство (гипомагнитная камера) для коррекции биофизического поля человека, выполненное в виде изолированной комнаты или замкнутой камеры с плоскими прямоугольными стенками из стальных листов, обеспечивающих изоляцию пациента от внешних физических полей электромагнитной природы, в частности гелиогеофизических полей (3). Недостатком данного устройства является то, что оно обеспечивает непрямую коррекцию биофизического поля путем временной изоляции пациента в неблагоприятные по гелиогеофизической обстановке дни от действия на его биофизическое поле внешних физических полей, что влечет за собой улучшение функционального состояния людей с высокой степенью чувствительности к резкому изменению гелиогеофизических полей.

Наиболее близким к заявленному является устройство для коррекции биофизического поля человека (4), включающее вертикально установленный полый металлический цилиндр из алюминиевого сплава толщиной 1,5-2 мм с отшлифованной внутренней поверхностью диаметром не менее 110 см, внутри которого расположено место для размещения пациента в положении сидя. Предполагается, что эффект коррекции достигается путем фокусировки в определенной зоне внутреннего пространства цилиндра и переадресовки (по законам оптики) на регуляторные зоны организма его собственных биофизических полей после усиления в зоне фокусировки взаимодействия

последних с внешними гелиогеофизическими полями, выполняющими роль синхронизаторов биоритмов человека.

Недостатком известного устройства является то, что оно не обеспечивает "очистку" биофизического поля человека от искажений, возникающих в процессе его жизни вследствие воздействия на него внешних электромагнитных и других полей. Это обуславливает недостаточный эффект коррекции поля на функциональное состояние или характер течения заболевания, обусловленного нарушением нормальной структуры биофизического поля человека.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является устранение искажений биофизического поля человека.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в предложенном устройстве цилиндр установлен на опоры в горизонтальном положении, во внутреннем пространстве его "головного" конца расположен аппарат гелий-неонового лазера, прикрепленный к корпусу цилиндра на подвижной опоре таким образом, чтобы луч лазера был направлен по центральной продольной оси внутреннего пространства цилиндра над телом пациента; место для размещения пациента выполнено из неметаллического материала в виде горизонтальной площадки, совпадающей в месте расположения по длине и ширине с соответствующими размерами цилиндра. При этом цилиндр выполнен в виде двух разъемных по горизонтали частей, подвижно закрепленных друг относительно друга, а площадка для пациента крепится к нижней (стационарной) части цилиндра.

Устройство для коррекции биофизического поля человека (фиг. 1) включает в себя полый цилиндр 1, выполненный из алюминиевого сплава, длиной 200-220 см, диаметром не менее 110 см, толщиной 1,5-2,0 мм с отшлифованной (зеркальной) внутренней поверхностью, установленный в горизонтальном положении на опорах 2. В "головном" конце внутреннего (рабочего) пространства цилиндра расположен корпус гелий-неонового лазерного аппарата 3 (стандартного аппарата, используемого в медицинской практике, например марки ЛГ-111, с длиной волны 700-760 нм), укрепленный на подвижной опоре 4 с возможностью изменения положения корпуса лазера по вертикальной и горизонтальной осям таким образом, чтобы луч лазера был направлен по центральной продольной оси внутреннего пространства цилиндра над телом пациента. Корпус лазерного аппарата соединен с блоком питания 5. В нижней части цилиндра расположена площадка 6 для горизонтального размещения пациента, соответствующая в месте крепления по длине и ширине размерам цилиндра и выполненная из неметаллического материала (для исключения искажения биофизического поля) толщиной 4-6 см.

Верхняя часть цилиндра укреплена с одной стороны на металлической раме 7, имеющей две подвижные опоры в виде колес 8 и с другой стороны - шарнирные опоры, находящиеся на боковых поверхностях площадки для размещения пациента. Для большей жесткости конструкции верхняя

часть цилиндра укреплена поперечным каркасом 9 с торцевых сторон; нижняя часть цилиндра, как указано выше, закреплена на четырех вертикальных опорах и жестко соединена с площадкой для размещения пациента. Благодаря такой конструкции верхняя часть цилиндра свободно смещается по всей длине относительно нижней (фиг. 2), позволяя пациенту разместиться на горизонтальной площадке в положении лежа, после чего верхняя часть цилиндра задвигается обратно, замыкая пространство цилиндра.

Обязательными условиями для получения активного рабочего пространства внутри конструкции и, следовательно, для достижения корректирующего эффекта являются

- размещение конструкции в помещении вне локальных магнитных и биолокационных аномалий;

- размещение конструкции в звукоизолированном помещении с использованием для освещения люминесцентных ламп;

- проведение процедур с учетом гелиогеофизической обстановки, поскольку эффект коррекции определяется гелиогеофизической ситуацией, к которой наиболее чувствителен пациент.

Работа устройства основана на эффекте концентрации отраженных биофизических полей человека (работы Н.А. Козырева) и их взаимодействия с лазерной системой. Предполагается, что в результате такого взаимодействия достигается восстановление нарушенного вследствие различных патогенных влияний энергетического гомеостаза (структуры биофизического поля человека).

Устройство работает следующим образом.

Пациента помещают в рабочем пространстве цилиндра в положении лежа. Фиксируют лазерный аппарат таким образом, чтобы луч лазера проходил по центральной продольной оси внутреннего пространства цилиндра над телом пациента. Пациенту предлагают выполнить процедуру релаксации в течение 5 мин, затем на 15 мин включают лазер.

Регистрацию эффекта коррекции биофизического поля человека осуществляют путем фотографической регистрации биофизического излучения пальцев обеих рук методом Кирлиан (5- 7) до и после сеанса коррекции в течение всего курса коррекции, а также спустя 1-3 месяца после завершения курса коррекции. Одновременно оценивают функциональное состояние пациента с использованием методов клинического и электрофизиологического исследований: опрос, осмотр, измерение частоты сердечных сокращений, артериального давления, электропараметров точек акупунктуры. Оценку психоэмоционального состояния пациента производят по шкалам Тейлора и Айзенка.

Общее количество сеансов на курс лечения - от 7 до 10.

Результаты применения устройства для коррекции биофизического поля человека.

Пример 1.

Пациентка К., 38 лет, предъявляла жалобы на повышенную утомляемость, плохой сон, частые головные боли, боли в

подложечной области после приема пищи, частые запоры. Диагноз: вегето-сосудистая дистония по смешанному типу, хронический гастродуоденит в стадии вялотекущего обострения, синдром раздраженного кишечника, шейно-грудной остеохондроз вне обострения.

Из опроса выяснилось, что характер работы пациентки связан с частыми нервными перегрузками, а ситуация дома сопряжена с рядом семейных проблем. Режим питания не соблюдается.

Объективно: при пальпации - живот умеренно болезненный в области эпигастрия, сердечные тоны ритмичные, шумов нет, частота сердечных сокращений (ЧСС) - 72 удара в мин, артериальное давление (АД) - 140/85 мм рт. ст., в легких дыхание везикулярное, хрипов нет. При проведении психофизиологического тестирования по шкалам Тейлора и Айзенка выявлена высокая степень невротизма, повышенная тревожность.

Анализ фотографических снимков пальцев обеих рук, выполненных по методу Кирлиан, показал наличие выраженных дефектов в короне, в виде выпадения отдельных сегментов около 25% площади, что свидетельствует о нарушениях биофизического поля пациентки (фиг. 3,а). После проведения первого сеанса пациентка отметила улучшение общего самочувствия, подъем настроения. АД - 120/80 мм рт. ст., ЧСС - 64 удара в мин. Показано улучшение характеристик биофизического поля: восстановление структуры свечения, отсутствие дефектов выпадения.

В течение последующих пяти сеансов практически полностью прекратились головные боли, улучшился сон, аппетит, нормализовалась функция желудочно-кишечного тракта. По данным психотестирования отмечено снижение уровня невротизма. В течение 1,5 мес. после коррекции жалоб на самочувствие не предъявлялось. После стрессовой ситуации появились ощущения внутреннего напряжения, некоторого недомогания. По снимкам Кирлиан (фиг. 3,б) - неровный контур свечения короны, стримеры перекрывают друг друга, выпадений сегментов нет, в сравнение с исходными данными - отсутствие выраженных нарушений биофизического поля пациентки. Проведено три сеанса коррекции, после чего отмечено улучшение самочувствия, снижение уровней невротизма и тревожности. Полностью восстановились нормальные контуры свечения по методу Кирлиан. В течение последующих 6 месяцев жалоб не предъявлялось. По объективным оценкам - ухудшения состояния нет.

Пример 2. Пациентка Д., 44 лет, поступила с синдромом артериальной гипертензии. После обследования поставлен диагноз: гипертоническая болезнь 2 стадии. Предъявлены жалобы на головные боли, боли в области сердца, повышенную утомляемость, подавленное настроение, метеозависимость. АД в пределах 150/100 - 220/110 мм рт.ст. Повышенная метеозависимость. Длительное время пациентка получала гипотензивные и седативные препараты, но эффект от лечения достигнут не был.

Анализ свечения по методу Кирлиан

показал наличие дефектов, приблизительно 30% площади короны (фиг.4,а). До начала первого сеанса лечения АД - 170/100 мм рт.ст., ЧСС - 78 ударов в мин. После проведения процедуры пациентка констатировала улучшение общего самочувствия. АД - 150/90 мм рт. ст., ЧСС - 66 ударов в мин.

На снимках по методу Кирлиан - отсутствие дефектов свечения, ровные контуры короны.

После проведения 5 сеансов коррекции полностью прекратились головные боли, улучшился сон, пациентка отметила состояние особой легкости, бодрости. АД стабилизировалось в пределах 130/80 -150/90 мм рт. ст. Отмечен эффект гипотензивных препаратов (ранее не дававших эффекта) в дозе в 6 раз меньшей, чем до поступления (по 0,5 таблетки утром и на ночь). Курс лечения завершен после 10 сеансов. Субъективные жалобы отсутствовали. АД сохранялось в прежних пределах (130/80 - 150/90 мм рт. ст.). При анализе газоразрядного свечения отмечено отсутствие дефектов, ровные контуры короны (фиг. 4,б). В течение последующих 3,5 месяцев на фоне приема 0,5 таблетки гипотензивных препаратов в сутки ухудшения самочувствия не было.

Пример 3. Пациентка Г., 25 лет поступила с диагнозом психоневроз. Предъявлены жалобы на кошмарные сновидения, появляющиеся как во время ночного сна, так и в легком дремотном состоянии в период дневного отдыха. Их появление было периодическим и не зависело, со слов пациентки, от предварительных изменений психологического состояния, в связи с какими-либо психоэмоциональными перегрузками. Со слов мужа пациентки, во время сна ее состояние можно охарактеризовать как крайне беспокойное: вздрагивания, вскрики, разговор во сне.

Срок давности проблемы - 3 года. В этот период времени имело место обращение к психотерапевту, попытки самолечения методом аутотренинга, путем приема седативных препаратов, но эффекта достигнуто не было.

По данным психофизиологического тестирования по шкалам Айзенка и Тейлор определен высокий уровень тревожности. Данных о существенном изменении соматического состояния не выявлено. Анализ газоразрядного свечения по методу Кирлиан показал наличие дефектов в виде выпадения отдельных сегментов до 30% площади короны, разветвленность стримеров, перекрытие их друг другом; контур внутреннего овала намечен четко (фиг. 5,а).

После проведения третьего сеанса пациентка отметила прекращение сновидений пугающего характера в период дневного

отдыха. Кошмары во время ночного сна сохранились, но не носили прежней яркости возникающих образов. После 11 сеанса сны пугающего содержания прекратились полностью, по данным тестирования отмечено снижение тревожности, невротизма. По данным, полученным с использованием метода Кирлиан, проявились ровные контуры короны, отсутствие выпадений сегментов (фиг. 5,б). Через месяц после завершения курса лечения отмечена стойкая ремиссия. По методу Кирлиан - яркое ровное свечение без крупных разрывов и дефектов, что можно расценивать как безусловно положительный корректирующий эффект воздействия.

Список использованных источников информации:

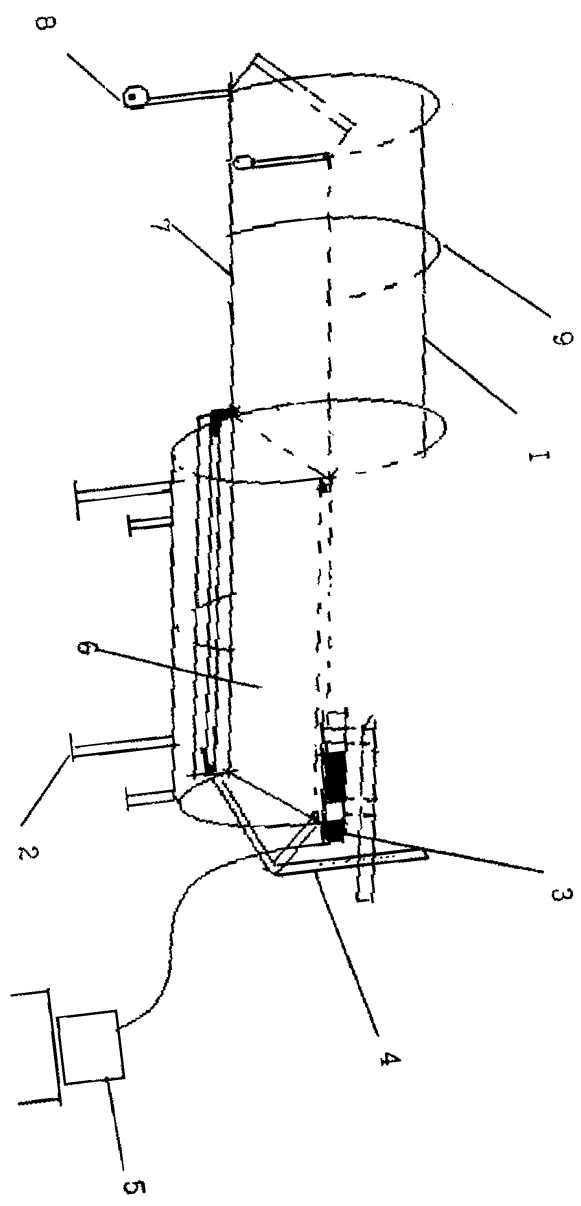
1. Mandel P. Energetic terminal point diagnosis. Kosmo-Medizin, Bd 1. - 1986.
2. Бернд Сенф. Вильгельм Райх. Открыватель акупунктурной энергии. Вестник биофизической медицины, -1992, 1, с. 35-46.
3. Биогенный магнетит и магнитоцепция. Новое в биомagnetизме/ Под. ред. Дж.Киршвинка, Д.Джонса, Б.Мак-Фаддена/- М.: Мир, 1989, т.1, с. 287.
4. Заявка РФ N 96113190/14.
5. Адаменко В. Г., Кирлиан С.Д., Кирлиан В.Х. Об исследовании биологических объектов в высокочастотных электрических полях. сб.:Вопросы биоэнергетики.- Алма-Ата, 1969, с. 19-26.
6. Кирлиан С.Д., Кирлиан В.Х. В мире чудесных разрядов. М.:Знание, 1964.
7. Коротков К.П. Эффект Кирлиан.- Санкт-Петербург; 1995.

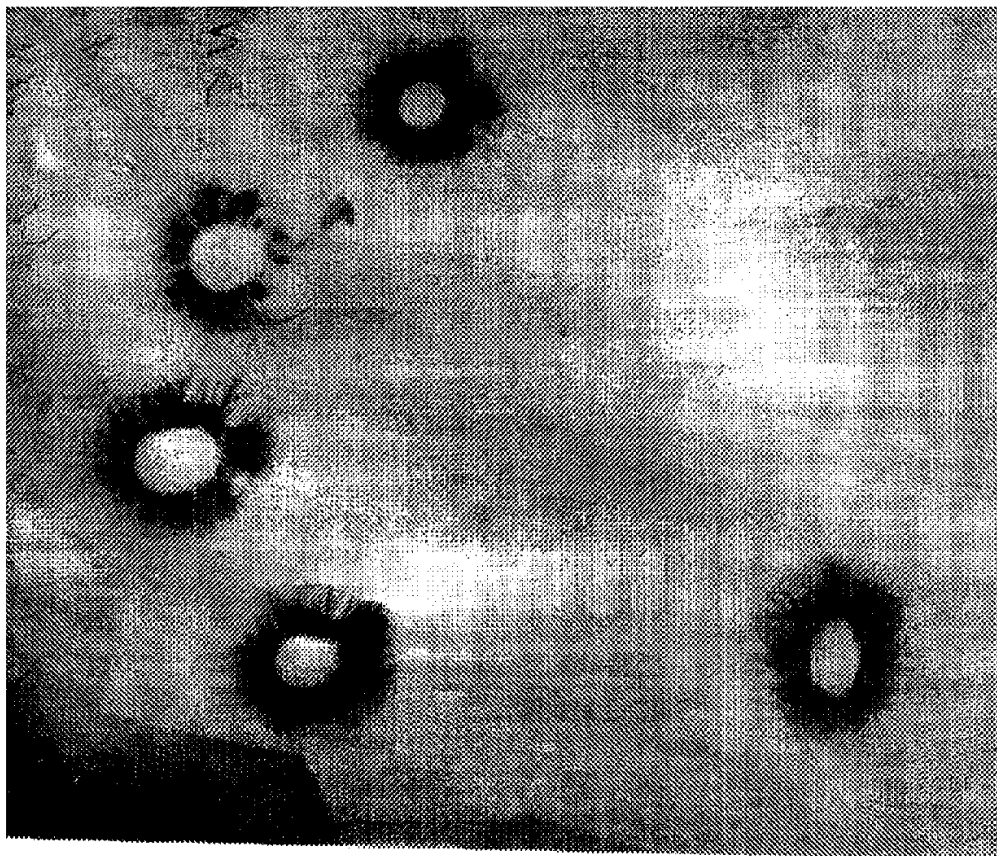
Формула изобретения:

1. Устройство для коррекции биофизического поля человека, содержащее полую камеру, отличающееся тем, что полая камера выполнена в виде цилиндра из алюминиевого сплава, установленного в горизонтальном положении на опоры, в полости цилиндра расположены гелий-неоновый лазер, прикрепленный к концу цилиндра на подвижной опоре так, чтобы луч лазера был направлен вдоль продольной оси цилиндра над телом пациента, а также площадка для размещения пациента, закрепленная в горизонтальном положении на стенках цилиндра в его нижней части, выполненная из неметаллического материала и соответствующая по длине и ширине размерам цилиндра в месте ее крепления.

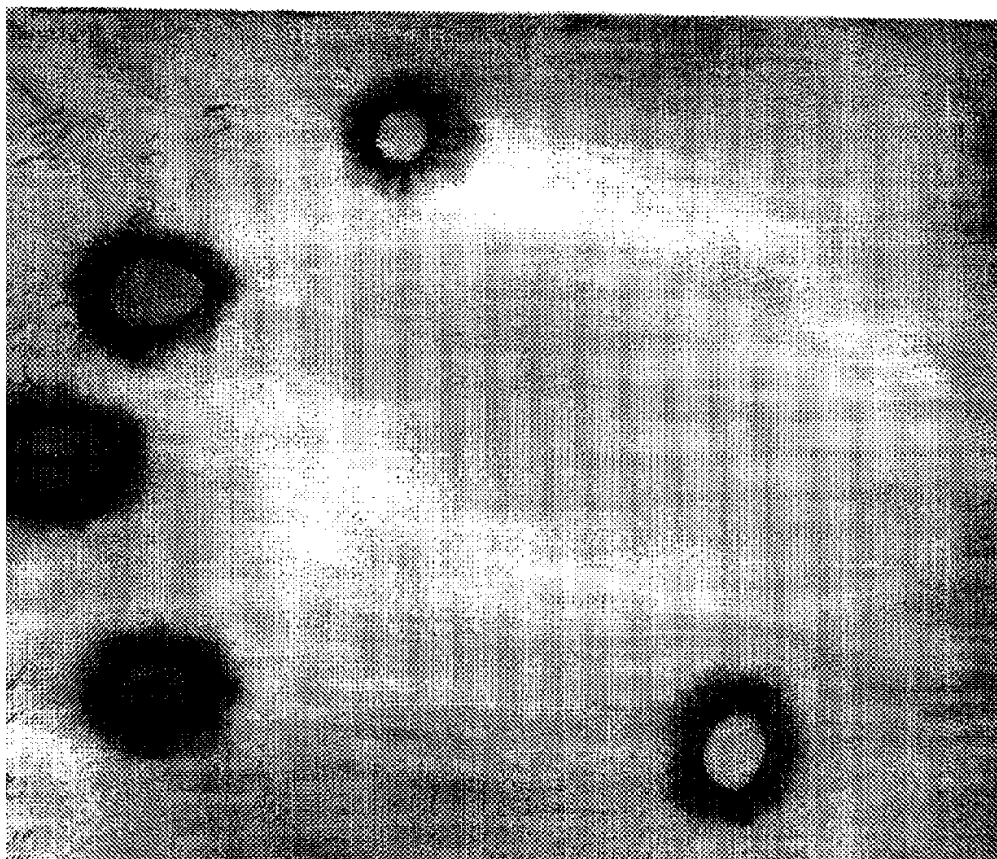
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что цилиндр выполнен в виде двух разъемных по горизонтали частей, верхняя часть цилиндра подвижно закреплена на нижней стационарной части, на которой жестко фиксирована площадка для размещения пациента.

2 1 4 1 3 5 7 C 1





Фиг.3а

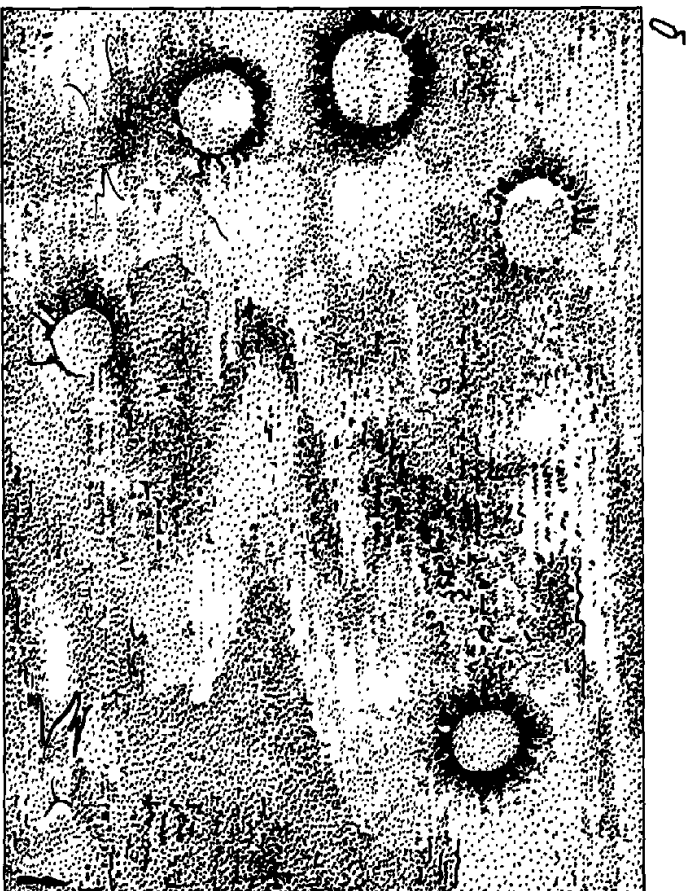
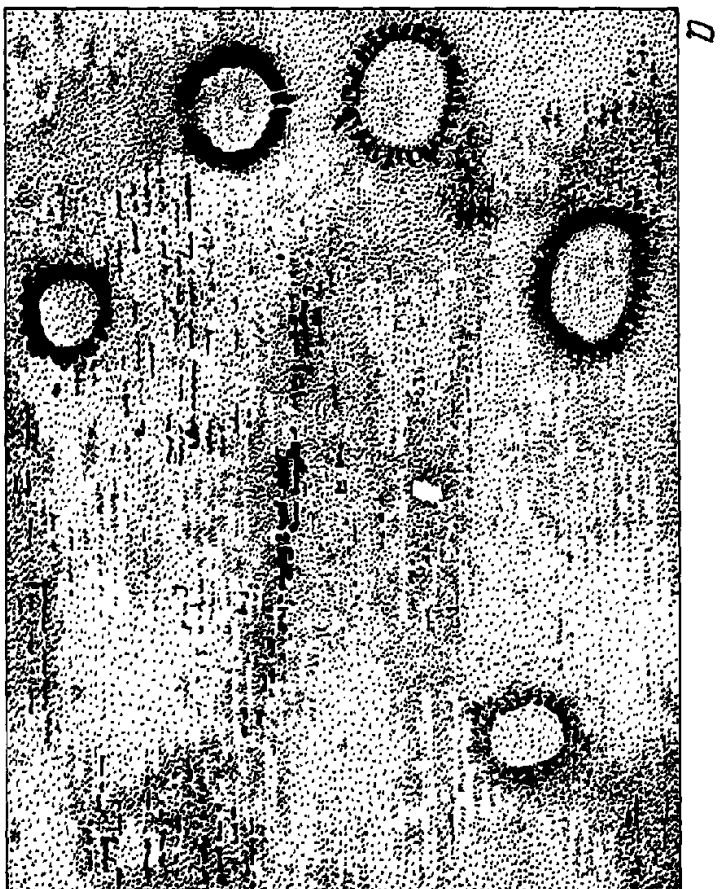


Фиг.3б

RU 2141357 C1

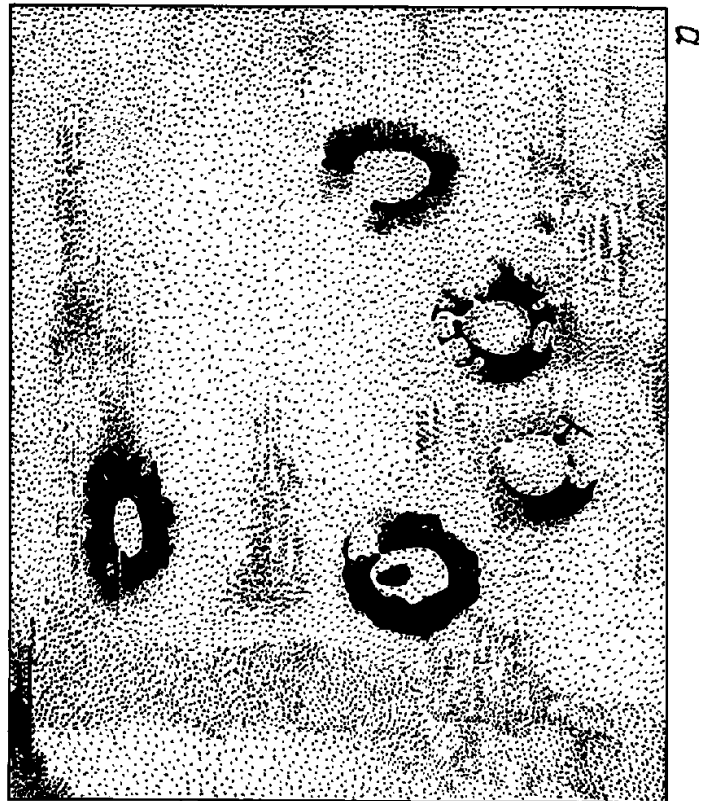
RU 2141357 C1

RU 2141357 C1

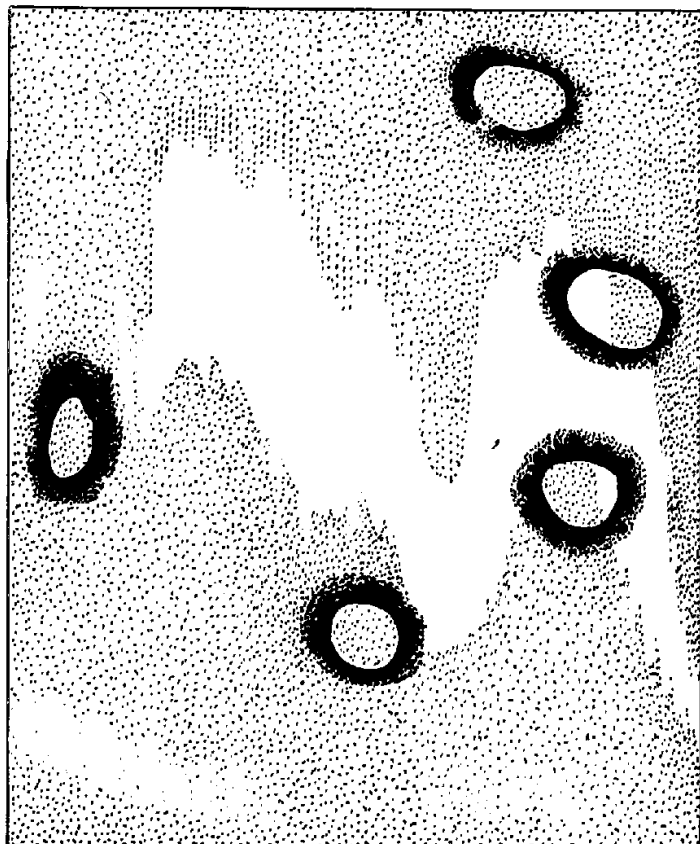


φ

RU 2141357 C1



2



5

Plus 5

R U 2 1 4 1 3 5 7 C 1

R U 2 1 4 1 3 5 7 C 1